

ITEM 270 : DYSPHAGIE OESOPHAGIENNE

Dysphagie = sensation de gêne ou d'obstacle à la progression du bol alimentaire survenant au cours de la déglutition

- **Dysphagie oropharyngée** : difficulté à initier la déglutition et à propulser le bol alimentaire dans l'œsophage, gêne/blocage localisé au niveau de la région cervicale → causes **ORL** ou **neurologique**

- **Dysphagie oesophagienne** : sensation de blocage ou gêne à la progression du bol alimentaire au niveau rétrosternale

- DD : **odynophagie** (douleur), **trouble de la déglutition**, **striction cervicale liée à l'anxiété**, **anorexie**, **satiété précoce**

Démarche diagnostic	1 ^{ère} étape Interrogatoire	- Electivité : pour les solides (dysphagie sélective = organique), associée aux liquides (dysphagie non sélective) ou électivité pour les liquides (dysphagie paradoxale = fonctionnelle) - Caractéristiques : mode de début, évolution, terrain, signes associés (RGO, signes ORL, AEG...)	
	2 ^{ème} étape Recherche d'une lésion organique	- Endoscopie oeso-gastro-duodénale = examen clé : diagnostic de tumeur de l'œsophage ou d'oesophagite, biopsie systématique ± guidée par colorants vaporisés en spray (lugol, acide acétique) → Autres examens : à discuter si sténose infranchissable ou aspect de compression extrinsèque - Scanner thoracique : lésion médiastinale, extension pariétale, médiastinale et ADP d'un cancer - Echo-endoscopie (en l'absence de sténose) : extension pariétale des tumeurs, ADP métastatiques, différencie lésion intra-murale sous-muqueuse et compression extrinsèque - Transit baryté : en 2nd intention en cas de sténose infranchissable	
	3 ^{ème} étape Recherche d'un trouble moteur	→ En cas d'endoscopie oeso-gastro-duodénale normale (élimine une lésion muqueuse ou une compression extrinsèque) et de biopsies normales (élimine une oesophagite à éosinophiles) - Manométrie oesophagienne haute résolution = examen clé : pression de repos du sphincter inférieur de l'œsophage et relaxation lors de la déglutition + analyse du péristaltisme oesophagien → Réalisation : - A jeun (6h), en décubitus dorsal ou latéral gauche (position horizontale de l'œsophage) - Après arrêt des médicaments modifiant la motricité digestive : neuroleptique, prokinétique, anticholinergique, dérivé nitré, inhibiteur calcique	
DYSPHAGIE LÉSIONNELLE	= Sténose organique de l'œsophage : découverte à l'endoscopie dans la majorité des cas		
	- Signes évocateurs : dysphagie prédominante sur les solides, aggravation progressive, retentissement sur l'état général		
	Sténose tumorale	- Cancer oesophagien : épidermoïde (terrain alcool-tabagique), ADK (sur endobrachyoesophagie)... - Cancer cardiaal étendu à l'œsophage - Tumeur extrinsèque : ADP, cancer bronchique, masse médiastinale	
	Sténose non tumorale	- Oesophagite peptique (le plus souvent) : sténose régulière, centrée, à la jonction 1/3 moyen-inférieur - Anneau de Schatzki : aspect de diaphragme du 1/3 inférieur de l'œsophage, associée à une RGO ou plus rarement à une carence martiale (syndrome de Plummer-Vinson/Kelly-Paterson) - Sténose sur oesophagite à éosinophile, caustique ou radique - Compression extrinsèque non tumorale	
Oesophagite non sténosante	Oesophagite à éosinophile	- Prédominance masculine, atopie associée dans 50% des cas (asthme, dermatite...) - Endoscopie : normale ou granité blanchâtre, muqueuse épaissie avec fissures linéaires verticales, sténoses uniques ou multiples, aspect en « pseudo-trachée » - Confirmation biopsique (systématique) : infiltration à éosinophiles (> 15/champ)	
		- Médicamenteuse : cycline, aspirine/AINS, alendronate, chlorure de potassium - Infectieuse (généralement chez l'immunodéprimé ou le diabétique) : candidose, CMV, herpès	
DYSPHAGIE FONCTIONNELLE	Achalasie	= Cardiospasme = absence complète de péristaltisme dans le corps de l'œsophage, généralement associée à une relaxation du SIO absente/incomplète à la déglutition et une hypertonie au repos : cause inconnue	
		Signes évocateurs	- Dysphagie : paradoxale (élective pour les liquides), capricieuse, intermittente, inopinée - Régurgitations (stase oesophagienne), douleur rétro-sternale constrictive, dénutrition - Endoscopie : normale au début, puis méga-œsophage à un stade avancé (dilaté, atone)
		Manométrie	- Absente totale de péristaltisme du corps de l'œsophage : critère obligatoire - Contraction non propagée d'amplitude très importante : achalasie « vigoureuse » - Hypertonie avec absence de relaxation du SIO fréquente
			Type

DYSPHAGIE FONCTIONNELLE	Achalasie	DD	- Tumeur infiltrante du cardia : possibles perturbations motrices = pseudo-achalasie néoplasique → Recherche par TDM ou écho-endoscopie si : tardif > 50 ans ou hyperpression importante du SIO - Maladie de Chagas : pseudo-achalasie due à un parasite d'Amérique du Sud (<i>Trypanosoma cruzi</i>)
		TTT	↳ pression du SIO : - Section musculaire chirurgicale par coelioscopie - Dilatation pneumatique sous endoscopie - Pharmacologique (efficacité inférieure) = dérivés nitrés sublinguaux, infiltration intra-sphinctérienne per-endoscopique de toxine botulique
	Maladie des spasmes diffus de l'oesophage		= Ondes péristaltiques anormales (non propagées, amples et répétitives) > 10% des ondes enregistrées, alternant avec un péristaltisme normal, SIO normal
	Œsophage « casse-noisette »		= Ondes péristaltiques anormales (prolongées, de très grandes amplitudes), prédominant dans la partie distale de l'oesophage, SIO normal
	Dysphagie fonctionnelle secondaire		- RGO - Collagénose : sclérodermie, dermatomyosite, lupus - Atteinte nerveuse ou musculaire : diabète, amylose, myasthénie